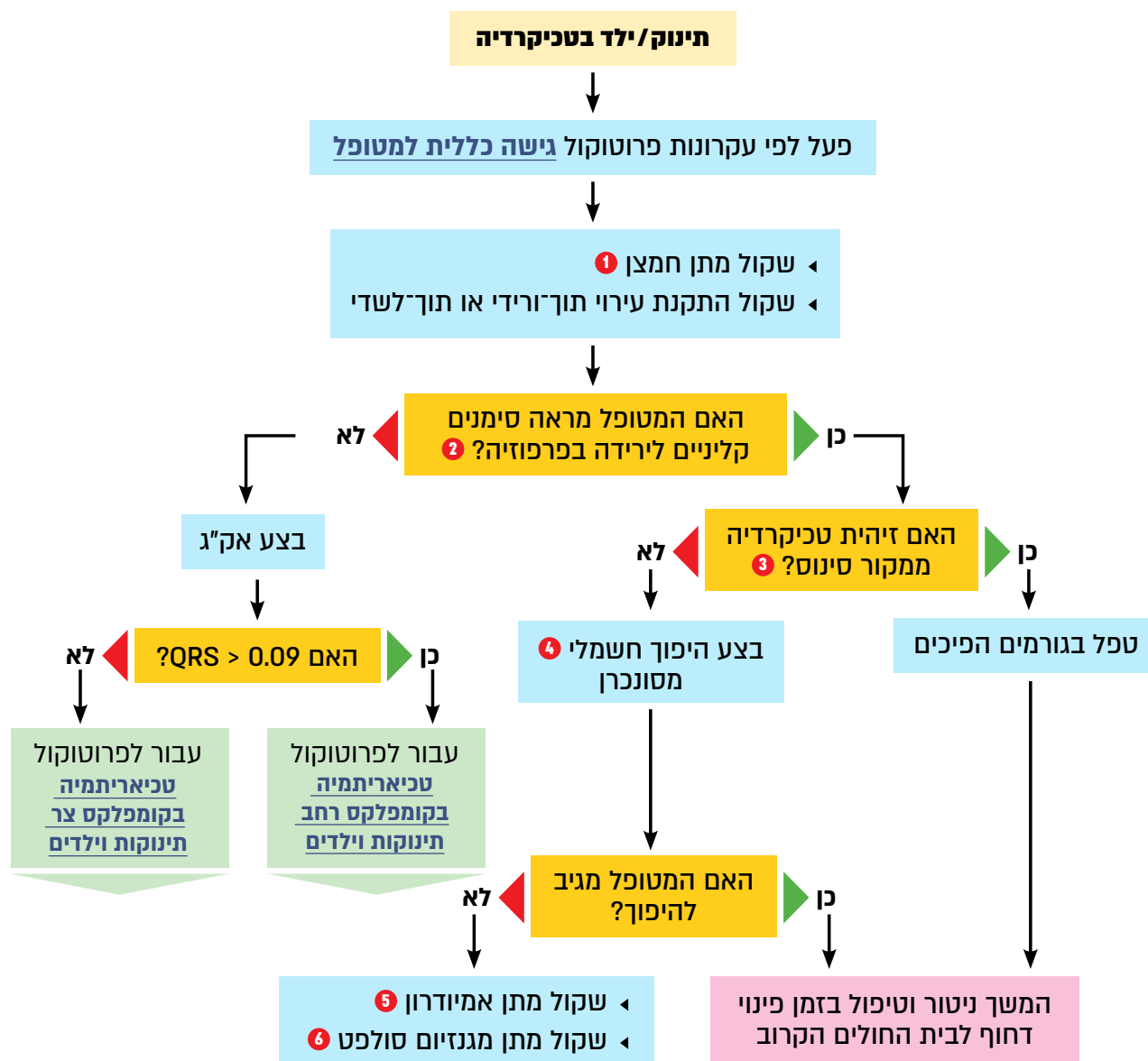


**1 הערכה וטיפול ראשוני**

- + תן חמצן אם המטופל מצוי במצוקה נשימתית או שערכי הסטורציה באוויר החדר נמוכים מ-94%.

2 סימנים קליניים לירידה בפרפוזיה

- + ירידה במצב ההכרה.
- + ערך לחץ הדם הסיסטולי נמוך מהנורמה לגיל.
- + טכיפניאה או סימני שוק.

3 סבירות גבוהה לטכיקרדיה ממקור סינוס

- + ממצאים בתשאול של המטופל וסביבתו.
- + קצב הלב נמוך מ-220 פעימות בדקה בתינוקות, ונמוך מ-180 בדקה בילדים.
- + גלי P ומרווח P-R קבוע.
- + מרווח R-R משתנה.

4 היפוך חשמלי מסונכרן

- + שקול מתן סדציה למטופל.
- + בצע עד שני ניסיונות רצופים.
- + אנרגיה התחלתית – 0.5-1 J/kg.
- + אנרגיה מקסימלית – 2 J/kg.
- + בהיעדר יכולת סנכרון בצע דפיברילציה.

5 אמיודרון

- מינון של 5 mg/kg במשך 20 דקות.

6 מגנזיום סולפט (TDP)

- מינון של 25-50 mg/kg במשך 10-15 דקות. עד למקסימום של 2 gr.

אבחנה

- + זכור, מקרה טכיקרדיה הנפוץ ביותר הוא ממקור סינוס ולרוב הוא תגובת הגוף למצבים קליניים שונים (כגון מחלת חום, היפוקסמיה, דהידרציה, סטרס).
- + גבול הנורמה העליון לדופק לפי גיל –
 - עד 3 חודשים – 210 פעימות בדקה.
 - מ-3 חודשים ועד בני שנתיים – 190 פעימות בדקה.
 - מבני שנתיים עד 10 שנים – 140 פעימות בדקה.
 - בני 10 ומעלה – 100 פעימות בדקה.
- + ערכי לחץ דם סיסטולי מינימליים לפי גיל –
 - מבני חודש עד שנה – 70 mmHg.
 - מבני שנה עד 10 – 70 mmHg + (גיל X 2).
 - בני 10 ומעלה – 90 mmHg.
- + אם אפשר, בצע אק"ג מלא טרם ההחלטה על טיפול, למעט במקרים שבהם המטופל מראה סימנים ברורים לירידה בפרפוזיה.

טיפול

+ טיפול תומך –

- מתן חמצן – אם ערכי הסטורציה נמוכים מ-94% או שהמטופל מציג דיספניאה.
- מתן עירוי נוזלים – למטופלים הסובלים ממחלת חום או מציגים סימני התייבשות.
- טיפול בכאב (אנלגטיקה) – לפי הצורך ולפי הוראות פרוטוקול [הטיפול בכאב](#).
- הורדת חום.

+ ביצוע סדציה –

- דורמיקום – מתן ב-IV במינון של 0.1 mg/kg. מנה מקסימלית 5 mg.
- אטומידאט – במינון של 0.2-0.3 mg/kg.

+ תרופות אנטי־ארייתמיות – אמיודרון –

- אין לתת לחולים עם רגישות מוכרת ליוז או הסובלים מפרה־אקטיטציה (WPW).
- אפשר לתת עד שתי מנות נוספות בהפרש של 10 דקות אם המטופל לא מגיב למנה הראשונה.
- אפשר לנסות היפוך חשמלי נוסף לאחר העמסת אמיודרון.